

المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة رؤية سوسيولوجية

رضوى إبراهيم عزمي*

dodaazzmy17@gmail.com

ملخص

استهدفت الدراسة الحالية محاولة رصد وتحليل الأسباب والعوامل التي دفعت صناع القرار إلى إطلاق المبادرات الصحية وتحديد الفئات المستفيدة منها وماهية آليات تحقيق تلك المبادرات وتأثير تطبيقها وانعكاسها على الفرد والمجتمع ، وتحقيقاً لذلك قدمت الدراسة تساؤلاً رئيسياً يتمثل في ما هي الأسباب التي دفعت الدولة لإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية.

وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية معتمدة في منهجيتها في تحليل وتفسير الأشكالية على أسلوب المسح الاجتماعي على عينة عمدية من المواطنين المستفيدين من المبادرات الرئاسية الصحية.

وتوصلت الدراسة الحالية إلى أن :

- كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (1) بمعدلات نوع المبادرة التي استفادوا منها عن احتلال مبادرة دعم صحة المرأة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٦٦,٨ % .
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (4) لاسباب المشاركة في المبادرات الصحية من قبل افراد العينة عن احتلال الوقاية من الامراض في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٣٩,٦ %
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (9) عن الوسائل والاليات التي تعتمد عليها الدولة لتفعيل المبادرات الصحية عن احتلال دعم البحث العلمي والابتكار في الصحة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٤٠,٠ % .

كلمات مفتاحية: المبادرات الرئاسية - التنمية الصحية المستدامة

* باحثة ماجستير بقسم علم الاجتماع- كلية الآداب- جامعة الفيوم.

تمهيد:

شهد العالم في أقل من ٢٠ عاما ما يقرب من ١٠٠ مبادرة صحية عالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويتعبئة وتمويل من الحكومات من أجل مواجهة انتشار الأمراض، الأمر الذي ساعد على تعزيز النظام الصحي ، ومعالجة الاختلالات الموجودة بداخله ، وتسريع عجله التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية ، فعندما يكون النظام الصحي قادراً على منع تهديد الصحة العامة أو اكتشافها أو معالجتها بفاعلية ، فإن المستفيد الأكبر هو المجتمع كله ، وفي الوقت نفسه تستفيد العديد من الجهات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.^١

ولقد أصبحت مسأله الصحة من الشواغل ذات الأهمية الكبرى في مجال التنمية في مختلف المجتمعات، سواء في تلك المتقدمه أو المتخلفه ، وذلك بوصفها من بين أهم العوامل التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأحد مؤشراتنا على حد سواء ؛ ففي حين تمثل الصحة قيمه في ذاتها ، فإنها تعتبر كذلك مفتاحاً لزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ، فالتنمية الصحية تمثل عنصراً هاماً في عمليه التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ حيث من غير الممكن تحقيق تنمية حقيقية ، من دون تحسين وتطوير الأوضاع الصحية للإنسان الذي هو نواة التنمية وهدفها ، ذلك أن الإنسان المكتمل صحياً هو القادر على بناء تنمية صحيحة ومستدامة.^٢

فهناك ترابط وثيق بين الصحة والتنمية ؛ حيث تعتبر الصحة مساهمة في التنمية ومستفيدة منها ، وبالتالي فهي جزء (لا يتجزأ) من جميع أهداف التنمية المستدامة ، والرؤية الغالبة لأهداف التنمية المستدامة هي أن جميع البشر يمكنهم أن يحققوا إمكاناتهم بكرامة ومساواة وفي بيئة صحية ، ويتمتعون بحياه مزدهرة ومستوفية.^٣

^١ محمد كمال احمد: المبادرات الصحية الرئاسية وتغيير المنظومة الصحية في مصر ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجزء ٢ ، العدد ٣٠ ، كلية الآداب ، جامعة السويس ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٠م ، ص ٦٥.
^٢ بومعروف إلياس و آخرون: من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر ، مجلة الباحث ، المجلد ٧ ، العدد ١ ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، الجزائر ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٧.

^٣ Kunt Lonnorth, ET.all "The Who's New End TB Strategy In The Post -2015 Era Of The Sustainable Development Goals", world health organization, Geneva, Switzerland ,2015, p 148.

تؤكد أهداف التنمية المستدامة **SDGs** على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠م وهذا يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص والمجتمعات - في كل مكان في العالم - على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها - سواء التعزيزية أو الوقائية أو العلاجية أو التأهيلية أو المخففة للألام - من دون مواجهة أية ضائقة مالية ، كما إن التغطية الصحية الشاملة ليست حلاً للمستقبل بل إنها بالفعل أمر واقع في العديد من البلدان ، ومع ذلك ، فبدون خدمات صحية عالية الجودة يمكن أن تظل وعداً فارغاً ويبنى هذا التقرير التأسيسي حالة تقنية وسياسية قوية للاستثمار في خدمات صحية جيدة وإن الهدف الأسمى هو عالم أكثر صحة وأكثر أماناً وإنصافاً.^٤

وان توفير الصحة للجميع هو شرط مسبق ومؤشر لتحقيق التنمية المستدامة ، ولا بد من العمل عبر القطاعات في جميع البلدان لتحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام ٢٠١٥م تشمل هدفاً مقترحاً مفاده ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار ، وغاية مقترحة مفادها تحقيق التغطية الصحية الشاملة والعكس صحيح ، إذ يكتسب تحقيق مجموعة أهداف التنمية المستدامة المقترحة بحلول عام ٢٠٣٠م أهمية حاسمة من أجل الصحة والإنصاف في مجال الصحة ؛ أخذاً في الحسبان أن معظم أهداف التنمية المستدامة عبارة عن محددات اجتماعية واقتصادية وبيئية للصحة مثل: الفقر، الجوع ، الأمن الغذائي والتغذية ، التعليم الشامل والجيد ، تحقيق المساواة بين الجنسين ، توفر المياه وخدمات الصرف الصحي ، الطاقة ، النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ، العمالة والعمل اللائق ، جعل المدن آمنة ومستدامة ، تغير المناخ ، إقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع وعلاوة على ذلك ، تعتبر الصحة عاملاً مسهماً في تحقيق هدفين مقترحين آخرين من أهداف التنمية المستدامة أي الإنصاف والشاركة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوجد أيضاً روابط بين الصحة والأهداف الأربعة المقترحة المتبقية

^٤ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير : تقديم خدمات صحية عالية الجودة : ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة ، منظمة الصحة العالمية ، جنيف ، ٢٠١٩م ، ص ٥ .

من أهداف التنمية المستدامة وهي: التصنيع والابتكار، أنماط الاستهلاك والإنتاج ، استخدام المحيطات والبحار والموارد البحرية ، استخدام النظم الإيكولوجية البرية.^٥

لذلك فإن تطور الجانب الصحي للفرد والمجتمع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطور الخدمات الصحية وتوفر المؤسسات والهيكل الصحية والمعدات الطبية وتوفر الأدوية وغيرها ، بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى كما ونوعاً وتعتبر الدولة ووزارة الصحة المسؤول الأول عن توفير الخدمات الصحية لكل أفراد وشرائح المجتمع ، باعتبار أن العلاج حق شرعي من حقوق الأفراد ، أكدت عليه مختلف الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما أن الخدمات الصحية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كبير ، وعليه فالدول والحكومات مطالبة بتطوير هذا القطاع من خلال وضع المخططات الصحية الملائمة والعمل على التوزيع العادل للهياكل والمؤسسات الصحية والمرافق المختلفة مما يضمن توفر العلاج لمختلف شرائح المجتمع لذلك تعتبر الخدمات الصحية مقياساً ومؤشراً هاماً لتطور المجتمعات والدول ؛ حيث أصبح يقاس تطور الدول بتطور القطاع الصحي في هذه الدول ، والعكس صحيح وعليه فالدول والحكومات مطالبة اليوم قبل الغد بضرورة القضاء على مختلف السلبيات والنقائص التي يعاني منها قطاع الصحة ، وتسطير مخططات وبرامج صحية تنموية تساهم في رفع وتحسين الخدمات الصحية المقدمة كما ونوعاً^٦.

أولاً : مشكلة الدراسة :

انطلاقاً من رؤية الدولة المصرية بأن القضايا المتعلقة بالصحة ليست مجرد مشاكل صحية وإنما هي عوامل تعيق تحقيق التنمية الصحية المستدامة ، فضلاً عن إن تلك المشكلات لا تشكل تهديداً للأمن الإنساني فقط ، وإنما لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع المصري كله ، ولهذا انطلقت مشكلة الدراسة في محاولة لرصد وتحليل الأسباب والعوامل التي دفعت صنّاع القرار إلى إطلاق المبادرات الصحية وتحديد

^٥ منظمة الصحة العالمية: المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية: إجراءات مستدامة عبر القطاعات من أجل تحسين الصحة والإنصاف في مجال الصحة (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة) ، جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون ، البند ٥-١٤ من جدول الأعمال المؤقت ١٨ مايو ٢٠١٥م ، ص ٥.

^٦ سعيدة رحمانية : تقييم الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العمومية من وجهة نظر المرضى " دراسة ميدانية بالمؤسسات الصحية العمومية بمدينة قسنطينة " ، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، المجلد ١٣ ، العدد ٤ ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، ٢٠٢١م ، ص ١٩٠.

الفئات المستفيدة منها وماهية آليات تحقيق تلك المبادرات وتأثير تطبيقها وانعكاسها علي الفرد والمجتمع .

ثانياً : أهمية الدراسة :

• الأهمية النظرية :

١. إثراء مجال علم الاجتماع الطبي بموضوع جديد وهو المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية الصحية المستدامة في ضوء رؤيه مصر ٢٠٣٠ م .
٢. إظهار العلاقة البيئية ما بين علم الاجتماع الطبي والتنمية .
٣. إظهار أهمية المبادرات باعتبارها أحدث أجهزة الإنذار والرقابة في المجال الطبي.

• الأهمية التطبيقية :

١. قيام وسائل الإعلام بحث وتوعية الأفراد بأهمية المبادرات الرئاسية .
٢. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنمية هذه المبادرات.
٣. عقد ورش عمل لتأهيل العاملين بالقطاع الطبي علي آليات تنفيذ هذه المبادرات.

ثالثاً : أهداف الدراسة :

- الوقوف على الأسباب التي دفعت الدولة إلى انطلاق المبادرات الصحية الرئاسية.
- العوامل التي تساعد على تحقيق التنمية الصحية المستدامة.
- العوامل التي تتوقف عليها نجاح تلك المبادرات الصحية الرئاسية .
- التعرف علي الفئات المستهدفة من تلك المبادرات الصحية الرئاسية .
- التعرف على الوسائل و الآليات التي تساعد على تحقيق المبادرات الصحية الرئاسية .
- رصد المردود الإيجابي و السلبي لتلك المبادرات الصحية الرئاسية على الفرد و المجتمع .

رابعاً : تساؤلات الدراسة :

- ١ - ما هي الأسباب التي دفعت الدولة لإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية ؛ ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية:
- ١ - إلى أي مدى أسهمت المبادرات الصحية التي اطلقتها الدولة في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ؟

- ٢ - إلى أي مدى أسهمت المبادرات الرئاسية الصحية في رفع الوعي الطبي للأفراد فيما يتعلق بالأمراض ؟
- ٣ - إلى أي مدى أسهمت المبادرات الرئاسية الصحية في تقليل حدة الازمات الصحية داخل القطاع الصحي ؟
- ٢ - ما هي العوامل التي تتوقف عليها نجاح تلك المبادرات الرئاسية؛ و يتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية:
 - ١ - كيف يتوقف نجاح المبادرات الرئاسية الصحية من حجم التمويل المتاح ؟
 - ٢ - كيف يتأثر نجاح المبادرات الصحية الرئاسية بكفاءة العاملين بالقطاع الطبي ؟
 - ٣ - كيف تؤثر مدى توافر قاعدة بيانات أساسية عن المرضى في نجاح تلك المبادرات الرئاسية الصحية؟
 - ٤ - كيف يؤثر توفر الأدوية و المستلزمات الطبية في نجاح تلك المبادرات الصحية الرئاسية ؟
- ٣ - من الفئات المستهدفة من تلك المبادرات ؟
- ٤ - ما الوسائل و الآليات التي ساعدت على تحقيق المبادرات الرئاسية الصحية ؛ ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤلات الفرعية:
 - ١ - إلى أي مدى تؤثر وسائل الاعلام في تعريف الأفراد بأهداف المبادرات الرئاسية الصحية ؟
 - ٢ - كيف تساعد مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف المبادرات الصحية الرئاسية؟
 - ٣ - كيف تساعد توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تحقيق أهداف المبادرات الصحية الرئاسية ؟
- ٥ - التعرف على المردود الإيجابي و السلبي المترتب على تلك المبادرات الصحية الرئاسية ؟

خامساً : مفاهيم الدراسة :

مفهوم المبادرات الرئاسية :

وتعرف **المبادرات الرئاسية** بأنها: مبادرات تقوم بها الدول أو المؤسسات أو الأفراد وتشتمل فى برامج أعمالها أنشطة متنوعة فى مجالات مختلفة ، وتعرف أيضا بأنها قيام شخص ما باتباع نهج نشط ومبتكر فى أهداف العمل والمهام ، والاستمرار فى التغلب على الحواجز والصعوبات ويترتب عليه أن البيئة يتم تغييرها من قبل الفرد والمجتمع ، ويمكن تعريف **المبادرات الرئاسية إجرائيا وفقا للآتى** :أنها مجموعة المبادرات التى قام بإطلاقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى تحظى باهتمام السبد الرئيس كما أنها تلقى الدعم من المؤسسات الحكومية والغير حكومية تستمد الدعم المادى من صندوق تحيا مصر ، ومن موازنة الدولة والتبرعات وتتبع مؤسسة رئاسة الجمهورية فى الإشراف العام على التنفيذ وكذلك رئاسة مجلس الوزراء وهى تضم عدداً من المبادرات^٧.

ويقصد بالمبادرة الرئاسية إجرائياً:

هي المشاريع التي يقدمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدة والنهوض بالشعب المصري اجتماعيا وصحيا وأطلق عدداً كبيراً من المبادرات الصحية التي تسير علي نهج رؤية مصر ٢٠٣٠ منها :

- مبادرة نور حياة .
- مبادرة دعم صحة المرأة المصرية .
- مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار .

التنمية الصحية المستدامة:

تعد **التنمية الصحية** من أحدث ما ظهر من أنواع التنمية العديدة ، وهي بدورها مرتبطة ومتغلغلة في كل عنصر من عناصر التنمية المختلفة ، لذلك تعد قضية التنمية الصحية عند كثير من دول العالم ، من القضايا المعاصرة الهامة التي زاد الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية ، كما أصبحت الصحة من الأمور الأكثر أهمية في مجال التنمية وذلك بوصفها من العوامل التي تسهم في التنمية المستدامة و أحد مؤشراتنا ، لذا **تعرف التنمية الصحية:** " على أنها كافة الجهود المنظمة التي ترسم وفق تخطيط مرسوم بهدف تحسين الصحة، سواء تعلقـت هذه الجهود بالعناية الصحية بالأفراد أو تقديم الخدمات الصحية

^٧ نبيلة محمد لطفي : عرض تحليلي للمبادرات الرئاسية باستخدام نماذج الممارسة العامة فى الخدمة الاجتماعية للمساهمة فى تحقيق جودة الحياة، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية ، المجلد ٣٢ ، العدد ١ ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة الفيوم ، جمهوريه مصر العربية ، ٢٠٢٣م ، ص ٥٥٣ .

اللازمة بشكل عادل بغية الوصول لتغطية شاملة ، كما أن قرار جمعية الصحة العالمية رقم 33 - 58 الذي صدر عام 2005م يؤكد أن كل شخص ينبغي أن يكون قادراً على الحصول على الخدمات الصحية وألا يتعرض لمصاعب مالية من جراء ذلك ^٨.

لذلك فإن التنمية الصحية المستدامة هي مجموعة البرامج التي تعنى بالقطاع الصحي على اختلاف أنواعه (نوعية الخدمات ، العتاد المستعمل ، التكنولوجيا المعتمدة) والتي هدفها تنمية القطاع الصحي والرفي به إلى درجات اعلي مما عليه ، كما أنها " وضع خطة تخص الجانب الصحي من أجل تحسين القطاع الصحي من كل الجوانب المتعلقة به مع تجنب كل العقبات والصعاب التي كانت موجودة سابقاً " ^٩.

وتعرف بأنها " عملية تغيير معارف الأفراد إلى أنواع من السلوك والعادات تؤدي إلى الوقاية من الأمراض وعودتهم سريعاً إلى الصحة إذا انتابهم المرض ، وإلزام المواطنين بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسئولية نحو صحتهم وصحة الآخرين ^{١٠}.

والتنمية الصحية المستدامة تعني " ترجمة الحقائق ذات العلاقة بالصحة والمرض إلى نماذج من السلوك الصحي الملائم من قبل الأفراد والأسرة والمجتمع " ^{١١}.

كما أن التنمية الصحية هي نظام معقد من المدخل المتفاعل للاستعادة وإدارة وتحسين صحة الإنسان التي لها قاعدة أيكولوجية قابلة للاستمرار بيئياً واقتصادياً و اجتماعياً إلى أجل غير مسمى ، التي تعمل بانسجام مع الجسم البشري والبيئة غير البشرية على حد سواء ، والذي لا ينتج عنه آثار غير عادله أو غير متناسبة على أي عنصر هام يساهم في نظام الرعاية الصحية ، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة ، كما

^٨ محمود حبيب : دراسة واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي ٢٠٠٠م - ٢٠١٠م ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٣٧ ، العدد ٢ ، جامعة تشرين ، سوريا ، ٢٠١٥م ، ص ٣٠٠.

^٩ بن عرار بقة و سبيهم عبدالعزيز : مؤشرات التنمية الصحية في الجزائر ، مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم الانسانية والاجتماعية ، المجلد ١٠ ، العدد ٤ ، جامعة زيان عاشور ، الجزائر ، ٢٠٢٣م ، ص ٧٤.

^{١٠} فاطمة محمد فؤاد: برنامج مقترح في خدمة الجماعة لتدعيم دور جماعة الهلال الأحمر في تنمية الثقافة الصحية للطلاب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٠٦م ، ص ٢٨.

^{١١} داليا عثمان إبراهيم : اتجاهات المرأة المصرية نحو استخدام الاعلام الرقمي في المجال الصحي ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ، مجلد ١٨ ، العدد ٣ ، كلية الاعلام ، جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٩م ، ص ٤٢٩ .

ينبغي للمنشأة المستدامة أن تمكن مقدمي الرعاية الصحية من تحقيق أهداف الصحة والسلامة مع الحفاظ على الجدوى الاقتصادية والحد من استهلاك الموارد^{١٢}.

ويمكن تعريف **الاستدامة الصحية** بأنها: تخطيط وإدارة وتقديم الرعاية الصحية المنصفة التي تتسم بالكفاءة والفعالية ، والتي تساهم في التنمية الطويلة الأجل بطريقة مستدامة ، لذلك هناك بعض العوامل التي تؤثر على الاستدامة الصحية وهما : ١- النقص في الدوارد البشرية ٢- عدم المساواة ٣- سلامة الخدمات والتي تعني مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة ٤- ضعف الإنتاجية ٥- تراجع ثقة الجمهور وتغيير توقعاتهم في نظام الرعاية الصحية^{١٣}.

بناءً على ذلك تهدف التنمية الصحية المستدامة، في أي مجتمع وجدت،

لتحقيق ما يلي :

- ١- رفع الوعي والدعاية حول القضايا التي تتعلق بالصحة والبيئة والإعاقة ، والتي تستهدف الفئات الأكثر تهميشا ، من خلال تكوين جماعات الضغط ، نشر المعلومات ، إصدار الإصدارات ، البرامج التدريبية .
- ٢- تأسيس وتطوير نماذج ريادية على مستوى المجتمعات المحلية لتحسين الواقع الصحي والبيئي لهذه المجتمعات ، والتي يمكن من خلالها اختبار وتقييم هذه الاستراتيجيات والسياسات واستنتاج الدروس المستفادة منها ونشرها .
- ٣- المساهمة في تشجيع وتقوية التعاون والتكامل بين مختلف الهيئات والمنظمات العاملة في مجالات الصحة والبيئة والإعاقة، خاصة على مستوى المنظمات غير الحكومية المحلية منها والإقليمية .
- ٤- المساهمة في تمكين المجموعات والفئات المهمشة من خلال مساعدتهم في تكوين منظمات ممثلة لمصالحهم وحقوقهم^{١٤}.

^{١٢} رزقي نور الهدي : دور النفقات الصحية في تحقيق التنمية الصحية المستدامة في الجزائر للفترة ٢٠٠٠-٢٠١٨ بالمقارنة مع تونس والمغرب -دراسة تحليلية ، المجلة الجزائرية للمالية العامة ، المجلد ١٠ ، العدد ٢ ، جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر ، ٢٠٢٠ م ، ص ٥٦ .

^{١٣} تغريد حسن الغوطي : واقع الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والمؤسسات الأهلية الصحية وأثرها على استدامة الخدمات الصحية بقطاع غزة ، مجلة الاقتصاد والمالية JEF ، المجلد 9 ، العدد ٢ ، جامعة حسنية بن بو علي بالشفل ، الجزائر ، ٢٠٢٣ م ، ص ١٣٥ .

^{١٤} مؤيد اسعد ناجي : دور جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تحقيق التنمية الصحية من وجهة نظر العاملين والمستفيدين في شمال الضفة الغربية ، جامعة القدس ، ٢٠١١ م ، ص ١٦ - ١٧ .

- ٥- تحسين ورفع مستوى مؤشرات التنمية الصحية للسكان في بلد ما ، بهدف الوصول إلى أفضل نتائج صحية ممكنة التحقيق عن طريق اتباع الخطط و الاستراتيجيات المناسبة .
- ٦- العمل على تطوير نظام الرعاية الصحية الموجود ، ورفع مستوى خدماته المقدمة للمواطنين و تحسين أدائه .
- ٧- توفير التمويل اللازم لتطوير النظم الصحية وفقا للخطط و الاستراتيجيات الصحية الموجودة ، والتوزيع العادل بين مختلف المناطق الجغرافية للخدمات الصحي .
- ٨- يجب أن تركز الاستراتيجية الصحية على مفهوم الصحة و ليس على مفهوم المرض مما يعني توجيهها الرئيسي نحو الرعاية الصحية الأولية و ليس نحو الطلب العلاجي.
- ٩- العمل على تأمين الكوادر الصحية المناسبة (أطباء ، أطباء أسنان ، صيادلة ، ممرضين .. الخ) بهدف تغطية الحاجات الضرورية للكوادر الطبية في مختلف المناطق الجغرافيا .
- ١٠ - توفير المشافي والمراكز الصحية و العيادات الخارجية الحكومية اللازمة وزيادة عددها والعمل على زيادة عدد الأسرة وعدالة توزيعها بين مختلف المناطق الجغرافية .
- ١١ - رفع مستوى التغطية الصحية وزيادة عدد المستفيدين من أنظمة التأمين الصحي لكافة المواطنين^{١٥}.

لذلك فإن من أهم غايات التنمية الصحية المستدامة هو حق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، خاصة أن هناك اتساعا لمفهوم الصحة ، فلم يعد مفهومها يقتصر على عدم وجود المرض بل تعداه ليشمل حالة كاملة من الأداء العقلي والجسدي ، وبذلك يتسع مفهوم الصحة ليشمل ميادين أخرى ذات تأثير مباشر

^{١٥} محمود حبيب : دراسة واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي ٢٠٠٠م - ٢٠١٠م ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٣٧ ، العدد ٢ ، جامعة تشرين ، سوريا ، ٢٠١٥م ، ص ٣٠١.

عليها ، إذ إن العديد من العوامل الحاسمة في ميادين الصحة والمرض تقع خارج نطاق التحكم المباشر لقطاع الصحة ويقترن بالقطاعات البيئية^{١٦}.

ومن خلال ما سبق يمكن الخروج ببعض التوجهات الخاصة بالتنمية الصحية المستدامة تتمثل في :

- ١- العلاقة بين التنمية والصحة علاقة متبادلة فهي علاقة تأثير وتأثر .
 - ٢- تتجاوز التنمية المستدامة تحقيق الرفاهية الاقتصادية إلي ما هو أبعد من ذلك لتشمل الرفاهية الصحية وكل ما يرتبط بحياة الإنسان ليعيش حياة كريمة .
 - ٣- ترتبط الاستدامة في مجال التنمية الصحية بالأمن الصحي بما لا يؤثر علي نصيب الأجيال القادمة.
 - ٤- ترتبط التنمية الصحية المستدامة بقطاعات أخرى تؤثر علي صحة الإنسان منها الصرف الصحي والمياه والتعليم والبيئة^{١٧}.
- وبما أن التنمية الصحية جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة باعتبار أن الصحة غاية من غايات التنمية حيث تتوقف التنمية نفسها علي الصحة فعلي هذا الأساس يمكن تحقيق التنمية الصحية المستدامة من خلال:
- ١- بناء استراتيجية وطنية للتخطيط المستدام للرعاية الصحية ويتشارك في التخطيط أغلب المنظمات وافراد المجتمع المعنيين بالتنمية المستدامة .
 - ٢- تشجيع البحث العلمي للاستدامة الصحية ، والاستفادة من ثمار التقدم العلمي ، والعمل بزياده الوعي التكنولوجي طمعاً في زيادة الإنتاجية والتخطيط المستدام للرعاية الصحية .
 - ٣- الاهتمام بالصحة العامة والعمل علي استصلاح ما يمكن استصلاحه من المباني الصحية .

^{١٦} محفوظ عرابي: إرساء دعائم التنمية الصحية المستدامة في الجزائر من أجل تحسين ظروف المعيشة وتحقيق رفاهية المجتمع ، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، ٢٠٢٠م ، ص ٥١ .

^{١٧} حنان عبدالسلام : برنامج في الجغرافيا الطبية قائم علي نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات التفكير السابري والوعي بالتنمية الصحية المستدامة لدي طلاب المدارس الثانوية الفنية للمريض ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية ، العدد ١٣٧ ، جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢م ، ص ١٥٣ .

٤- التوازن في استهلاك الموارد الصحية ومراعاة الخبرة الوطنية والاستعمال الأكثر كفاءة

٥- التقييم المتعمق لأثار الاستدامة ، وتحديد الروابط القائمة بين التخطيط المستدام ومرافق الرعاية الصحية.

٦- وضع تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية ، فهناك أبعاد اقتصادية وبيئية في التنمية الصحية ؛ لذا يدرس البعد البيئي مع البعد الاقتصادي عن طريق الممارسة البيئية وضوابط مراقبتها^{١٨}.

ويقصد بالتنمية الصحية المستدامة إجرائياً :

أنها التنمية التي تساعد علي تلبية احتياجات المرضى من الجيل الحالي ، وضمان قدرة الأجيال المستقبلية علي الاستفادة أيضاً من تلك الخدمات عن طريق ممارسة بعض السياسات التي تهدف إلي تحقيق التوازن الصحي بين الأجيال ، وايضاً تهدف إلي تنظيم ورعاية المرضى ، والاهتمام بالعمليات الجراحية ، والتوزيع العادل للأدوية ، لضمان حصول المرضى علي رعاية صحية عالية تضمن حمايتهم وعلاجهم .

سابعاً : الإطار النظري للدراسة :

إعتمد البحث علي عدد من النظريات في تفسير قضايا الدراسة :

١- نظرية التنمية المستدامة : التي تقوم علي مجموعة من المبادئ الهامة : حيث لا يمكن لأي مجتمع أن يرقى درجات سلم التقدم ما لم يحسن تهيئة إمكاناته ، ويطور أنساق الحكم بما يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان، ويؤدي إلى تطوير قدرات البشر وتوسيع خياراتهم وفرصهم وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية^{١٩}.

لذلك فان التنمية ظاهرة نشأت مع نشأة البشرية ، إلا أنها لم تأخذ أهمية كبيرة من حيث البحث ، إلا بعدما تمحورت إشكالياتها في سؤال إنساني بسيط هو : لماذا هناك شعوب أصبحت غنية وأخرى لاتزال فقيرة؟، ومن هنا أصبح موضوع التنمية من المواضيع الهامة التي لقيت اهتماما من الباحثين في مختلف الميادين الاقتصادية ، والاجتماعية ،

^{١٨} المرجع السابق ، ص ١٥٦.

^{١٩} سلوي السيد عبدالقادر : الرؤية المجتمعية لتمكين الشباب والتنمية البشرية المستدامة :دراسة أنثروبولوجية ، مجله كلية الآداب للانسانيات والعلوم الاجتماعية ، المجلد ١١، العدد ٢٠ ، كلية الآداب ، جامعه الاسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٩م ، ص ١١٤٧.

والسياسية ، والثقافية ، والبيئية ، واعتبرته المنظمات العالمية وعلى حقا مكرساً لكل الشعوب ، خاصة الشعوب والدول النامية حتى تستطيع اللحاق بالدول المتقدمة ^{٢٠}.

وتطورت بعد ذلك بنية التنمية المستدامة في الفترة ما بين السبعينيات والتسعينيات من خلال سلسلة من المؤتمرات وقدم المفهوم لأول مره في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في ستوكهولم في السويد عام ١٩٧٢م ^{٢١}.

بعدها تم وضع تحديات التنمية المستدامة على المسرح العالمي بالإشارة إلي تقرير حدود النمو الصادر عن نادي روما عام ١٩٧٢م بنفس الطريقة بعد ثماني سنوات تم إعادته في تقرير قوي بعنوان استراتيجية الحفاظ على العالم: الحفاظ على الموارد الحية من أجل التنمية المستدامة ١٩٨٠م ، حيث جاء في مقدمته إلى أن البشر في سعيهم إلى التنمية الاقتصادية والتمتع بثروات الطبيعة ، يجب أن يتفهموا حقيقة ضرورة الحد من استخدام الموارد والقدرة الاستيعابية للنظم الأيكولوجية ، ويجب أن يأخذوا في الاعتبار احتياجات أجيال المستقبل الغرض من المنشور هو المساعدة في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموارد الحية حيث تم اعتماد هذه العبارة ونشرها في تقرير لجنة الأمم المتحدة المعنية بالبيئة والتنمية وفي عام ١٩٨٤م أقامت الأمم المتحدة مجموعة منفصلة مكونة من ٢٢ متخصص تم اختيارهم من الدول الأعضاء من الدول النامية والدول المتقدمة معا ، بهدف تحديد الاستراتيجيات البيئية طويلة المدى للمجتمع الدولي ^{٢٢}.

٢ - نظرية الدور :

التي تقوم علي مجموعة من المبادئ الهامة : حيث أضاف منظري النظرية أن الدور هو الطريقة التي يتوافق بها الأفراد مع المتوقع منهم نتيجة شغلهم مركز معين ، وينظر إلى

^{٢٠} رحالي حبيلة وآخرون : التنمية من مفهوم تنمية الاقتصاد إلى مفهوم تنمية البشر ، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع ، العدد ٣ ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ، ٢٠١٥م ، ص ٢٣٤.

^{٢١} اسلام صلاح : الاتجاهات النظرية في دراسة الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ، رساله دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة الفيوم ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢م ، ص ١٤.

^{٢٢} محمد فتحي عبد الغني : تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتاجه ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية السياسة والاقتصاد ، جامعة بني سويف ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٠م ، ص ٤١٤ .

درجة التوافق باعتبارها محصلة عمليات داخلية متعددة تؤثر على الأفراد ، واعتماداً على موقف التعامل تدرك هذه العمليات الداخلية في إطار مجموعات متغيرات مثل :

- ١ - الدرجة التي تتوحد بها التوقعات باعتبارها جزءاً من بناء حاجات الفرد .
- ٢ - المدى الذي يدرك به الأفراد ارتباط مجموعة خاصة من التوقعات بالجزاءات الايجابية والسلبية .
- ٣ - الدرجة التي تستخدم بها التوقعات باعتبارها مقياساً لتقييم الذات .
- ٤ - المدى الذي تعبر فيه التوقعات إما عن تفسيرات الاستجابات الواقعية للآخرين وإما عن مجرد توقع استجاباتهم .

وهكذا يعتمد ارتباط تلك العمليات الداخلية موقف تفاعل خاص ، على طبيعة المراكز والتوقعات المصاحبة فإن هذه العمليات أصبحت واحدة من الأهداف الرئيسية لنظرية الدور ، وبناء على ذلك أن الصورة الذهنية العليا لنظرية الدور تدور حول التأثيرات الحتمية للبناء الاجتماعي على التفاعل^{٢٣} .

ويهتم العالم ماكس فيبر بالدور الاجتماعي أكثر مما يهتم بأي موضوع آخر إذ يشكل الدور الاجتماعي المهيمن لنظريته الاجتماعية ؛ ذلك أنه يعرف علم الاجتماع في كتابه الموسوم نظرية التنظيم الاجتماعي والاقتصادي بالعلم الذي يفهم ويفسر السلوك الاجتماعي ، ويعني فيبر بالسلوك الاجتماعي أي نشاط أو حركة يقوم بها الفرد والتي تكون لها علاقة مباشرة بوجود الأفراد الآخرين في المجتمع ، علماً بأن سلوك الفرد يعتمد على ثلاث شروط رئيسية :

- ١) وجود الدور الذي يشغله الفرد والذي يحدد طبيعة السلوك الذي يقوم به .
 - ٢) استعمال الرموز السلوكية والكلامية واللغوية المتعارف عليها من قبل الأفراد عند القيام بالسلوك .
 - ٣) وجود علاقة اجتماعية تربط شاغل الدور مع الآخرين عند حدوث السلوك^{٢٤} .
- وتؤكد نظرية الدور على بعض المقترحات الآتية :

^{٢٣} جوناثان تيرنز : ترجمة محمد سعيد فرح : بناء نظرية علم الاجتماع ، منشأة المعارف ، جامعة الأسكندرية ، ٢٠٠٦م ، ص ٢١٨ - ٢٢١ .

^{٢٤} احسان محمد الحسن : النظريات الاجتماعية المتقدمة (دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة) ، دار وائل للنشر ، الطبعة ٣ ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠١٥م ، ص ١٦٠ .

١- يقضي الناس معظم حياتهم في المشاركة بوصفهم أعضاء للمجموعات والمنظمات.

٢- يشغل الأشخاص مراكز مختلفة .

٣- يترتب على كل من هذه الوظائف دور ويتم تحديد دور الشخص من خلال التوقعات .

٤- يقوم الأفراد عادةً بأدوارهم و يؤدونها وفقاً للمعايير السائدة ، بمعنى آخر أنهم ملزمون بتلبية التوقعات التي يحملها الآخرون لهم^{٢٥}.

ثامناً : الإجراءات المنهجية للبحث:

منهج المسح الاجتماعي (بالعينة) :

تم إجراء مسح اجتماعي بالعينة علي مجموعة من الأفراد المستفيدين من المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة من خلال الرجوع إلي مركز التعبئة العامة والغصاء ووزارة الصحة ، والحصول علي قائمة بالأفراد التي استفادت من تلك المبادرات .

أدوات ومصادر جمع البيانات :

الاستبانة :

تم تصميم استبانة مكونة من سبعة محاور :

المحور الأول : البيانات الأساسية .

المحور الثاني : البحث عن الاسباب التي دفعت الدولة الي اطلاق تلك المبادرات الرئاسية؟ والتعرف علي دورها في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

المحور الثالث : البحث عن العوامل التي تتوقف عليها نجاح المبادرات الرئاسية في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

المحور الرابع : البحث عن الوسائل والاليات التي ساعدت علي تحقيق المبادرات الرئاسية الصحية لاهدافها.

المحور الخامس : البحث عن دور المبادرات في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

²⁵ Leslie L. Hemphill: "Social Role Theory As A Means Of Differentiating Between First -Generation, Non-First – Generation College Students", Department of Counseling and Education, Physiology College of Education, KANSAS STATE UNIVERSITY, Manhattan, Kansas ,2008, P :33-34.

المحور السادس : البحث عن الصعوبات التي تواجه المبادرات في تحقيق اهدافها. ودور الدولة في رفع كفاءة وفاعلية المبادرات الصحية.

• **مجالات الدراسة :**

١ - **المجال الجغرافي :**

- (١) بعض قري محافظة الفيوم وهما (بني صالح / العدوه / سيلا) .
- (٢) بعض مراكز محافظة الفيوم وهما (مركز الفيوم / مركز سنورس / مركز طاميه) .

٢ - **المجال البشري :**

العينة عمدية قوامها (٢٥٠) مفردة من المستفيدين من تلك المبادرات الرئاسية الصحية .

٣ - **المجال الزمني**

- (١) جمع المادة النظرية وكتابة الفصول .
- (٢) إجراء الدراسة الميدانية وكتابة التقرير النهائي .

تاسعاً :نتائج الدراسة الميدانية ومعطياتها :

جدول رقم (1)

يوضح معدلات نوع المبادرة التي استفدت منها

نوع المبادرة التي استفدت منها	التكرارات	%
مبادرة ١٠٠ مليون صحة	٢٥	%١٠,٠
مبادرة دعم صحة المرأة	١٦٧	%٦٦,٨
مبادرة ضعف الإبصار	١٨	%٧,٢
مبادرة علاج فيروس سى	٣٠	%١٢,٠
مبادرة التقدم	١٠	%٤,٠
المجموع	٢٥٠	%١٠٠

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (1) عن احتلال مبادرة دعم صحة المرأة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٦٦,٨% ، وجاءت مبادرة علاج فيروس سى في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ١٢,٠% وجاءت مبادرة ١٠٠ مليون صحة في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ١٠,٠% وجاءت مبادرة ضعف الإبصار في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت ٧,٢% وجاءت مبادرة التقدم في المرتبة الخامسة ٤,٠% .

وتري الباحثة أن إحتلال مبادرة دعم صحة المرأة المصرية المرتبة الأولى يعكس أهمية الدور التي تقوم به المرأة سواء علي المستوي الأسري أو المجتمعي ويتماشي مع حجم الأعباء الجسدية والنفسية التي تتحملها المرأة المصرية والذي ينعكس بالضرورة علي حالتها الصحية . كما أن المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية التي تنظر للمرأة اعتبارها الركيزة الأولى في تحقيق التنمية الصحية المستدامة ومن الفئات الأولى صحياً بالرعاية .

جدول رقم (2)

يوضح العلاقة بين النوع ونوع المبادرة

كشفت نتائج الدراسة فيما يتعلق بالعلاقة الارتباطية بين النوع ونوع

٢١٤	المجموع	مبادرة التقدم		مبادرة علاج فيروس سي		مبادرة ضعف الابصار		مبادرة دعم صحة المرأة		مبادرة ١٠٠ مليون صحة		نوع المبادرة / النوع	
		%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت		
٠,٠٠١	٧٩,٣	10%	25	%٠,٠	٠	%٠,٠	٠	%٠,٠	٠	0%	0	%١٠,٠	٢٥ ذكر
		90%	225	%٤,٠	١٠	%١٢,٠	٣٠	%٧,٢	١٨	66.8%	١67	%٠,٠	٠ انثي
		%١٠٠,٠	٢٥٠	%٤,٠	١٠	%١٢,٠	٣٠	%٧,٢	١٨	%٦٦,٨	١٦٧	%١٠,٠	٢٥ المجموع

المبادرة عن فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوي دلالة ٠,٠٠١ وقيمة احصائية بلغت ٧٩,٣ حيث احتل مبادرة دعم صحة المرأة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٦٦,٨% ثم احتل مبادرة فيروس سي في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ١٢,٠% ثم احتل مبادرة ١٠٠ مليون صحة في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ١٠,٠% ثم احتل مبادرة ضعف الابصار في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت ٧,٢% ثم احتل مبادرة التقدم في المرتبة الخامسة بنسبة قد بلغت ٤,٠% وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين النوع ونوع المبادرة .

وتري الباحثة ان سبب احتلال مبادرة دعم صحة المرأة في المرتبة الاولى يرجع الي أن المبادرة تهدف إلى تحسين صحة المرأة وبالتالي تحسين جودة حياتها وحياة أسرتها، مما يدفع العديد من النساء للمشاركة ، وتقديم توعية

شاملة حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة العامة، مما يعزز الوعي الصحي للمرأة ويحسن من ممارساتها اليومية ، كما تركز المبادرة على الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية مثل السكري والضغط والسمنة، مما يزيد من فرص الشفاء ويقلل من المضاعفات ، و توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات التي يتم اكتشافها في إطار المبادرة يزيل العبء المالي عن كاهل المرأة ويشجعها على تلقي الرعاية الصحية.

ثم احتلت مبادرة فيروس سي في المرتبة الثانية وذلك لأن المبادرة مدعومة من القيادة السياسية، مما جعلها تحظى باهتمام واسع من قبل مختلف قطاعات الدولة والمجتمع، مما زاد من ثقة المواطنين في المبادرة ، وللتأكيد على أهمية الكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه، حيث أن العلاج المبكر يمنع تطور الفيروس إلى مراحل متقدمة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد ، وإيضاً عمل المبادرة على توفير بيئة صحية آمنة، من خلال التأكد من سلامة الدم والفحوصات الدقيقة للمعدات الطبية، مما زاد من ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة و انتشار مراكز الفحص والعلاج في مختلف المناطق، وتوفير خدمات صحية مجتمعية، جعلت من السهل على المواطنين الحصول على العلاج ، و توفير العلاج بالمجان أو بأسعار رمزية ساهم بشكل كبير في إقبال المواطنين على المبادرة، حيث كان علاج فيروس سي مكلفاً جداً في السابق .

جدول رقم (3)

يوضح أكثر الفئات المستهدفة من المبادرات الصحية

النسبة المئوية	التكرارات	الفئة المستهدفة من المبادرات الصحية
٤٠,٠%	١٠١	الشباب
٣١,٢%	٧٧	المرأة
٢٨,٨%	٧٢	كبار السن
١٠٠%	٢٥٠	المجموع

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (3) عن احتلال الشباب في المرتبة الأولى بنسبة قد بلغت ٤٠,٠% وجائت المرأة في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٣١,٢% وجاء كبار السن في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ٢٨,٨% ،

وترى الباحثة أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها ، وطريقها نحو النهوض والتقدم و يمثل الشباب حوالى ٦٠ % من التعداد السكانى لمصر وتعول عليهم الدولة فى خطط التنمية الحديثة، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، كما أنهم فى مرحلة تتميز بالسرعة وكثرة التطلعات والطموحات المتزايدة الأمر الذى يفرض عليهم نمط ثقافة غذائية تعتمد على الوجات السريعة والدسمة وهو ما يعرضهم للإصابة بالأمراض .

أما فئة كبار السن واحتلالهم المرتبة الثانية بنتائج الدراسة الميدانية فربما يرجع ذلك إلى حرص الدولة على الاحتفاظ بهم بوصفها شريكاً فعالاً فى خطط التنمية وكذلك التقليل من حجم الضغوطات على المؤسسات الطبية فضلاً عن رغبتهم الشخصية فى أن يعيشوا ما تبقى من عمرهم تحت مسمى الشيخوخة المثالية أو الشيخوخة الصحية .

جدول رقم (4)

يوضح اسباب المشاركة فى المبادرات الصحية من قبل افراد العينة

اسباب المشاركة	التكرارات	النسبة المئوية
الفحص الطبى المجانى	٧٥	٣٠,٠%
الوقاية من الامراض	٩٩	٣٩,٦%
العناية بالصحة العامة	٧٦	٣٠,٤%
المجموع	٢٥٠	١٠٠%

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (4) عن احتلال الوقاية من الامراض فى المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٣٩,٦% وجاء العناية بالصحة العامة بنسبة قد بلغت ٣٠,٤% وجاء الفحص الطبى المجانى فى المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ٣٠,٠%

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسته " Ross L. Prentice, Garnet .

" L. Anderson^{٢٦} فى الاهتمام وارتفاع نسبة متغير الوقاية من الأمراض.

ولم تستعرض أي من الدراسات السابقة " اسباب المشاركة فى المبادرات الصحية من قبل افراد العينة " .

²⁶ Ross L. Prentice, Garnet L. Anderson; "The Women's Health Initiative: Lessons Learned", Annual Review of Public Health, Volume 29, 2008

وفي ضوء الدراسة الراهنة فإن احتلال عامل الوقاية من الأمراض كأكثر عامل مشجع للمشاركة إلى وعي متزايد لدى الأفراد بأهمية الصحة العامة والوقاية ، لا سيما في ظل التحديات الصحية التي تواجه العالم مثل الأوبئة والأمراض المزمنة ، هذا الاتجاه يعكس اهتمام الأفراد ليس فقط بصحتهم الشخصية ، بل بصحة المجتمع ككل.

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية التنمية المستدامة التي تركز على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، فالصحة الجيدة تعتبر بعداً رئيساً للتنمية المستدامة (البعد الاجتماعي) ، إذ يعتبر وجود مجتمع يتمتع بصحة جيدة يعد شرطاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي كما ان الوقاية من الأمراض تساهم في تقليل الأعباء المالية على نظم الرعاية الصحية ، مما يسمح بتوجيه الموارد نحو تنمية قطاعات أخرى ، بما يحقق التوازن والاستدامة ، بالإضافة الي الإقبال على الأنشطة الوقائية يعزز من مشاركة المواطنين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر بناء وعي جماعي وتحفيز سلوكيات صحية طويلة الأمد.

جدول رقم (5)

يوضح العلاقة بين النوع والخدمات الصحية التي تقدمها المبادرات الصحية

الخدمات النوع	الكشف		الرعاية		العلاج بالمجان		الاشاعة والتحليل		العمليات		المجموع		٢١٤	
	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	ت	%	القيمة	الدلالة
ذكر	٦٦	%٢٦,٤	١٧	%٦,٨	٠	%٠,٠	٠	%٠,٠	٠	%٠,٠	٨٣	%٣٣,٢	٢٠٤,٣	٠,٠٠١
انثي	٠	%٠,٠	٢٥	%١٠,٠	٤٩	%١٩,٦	٥٥	%٢٢,٠	٣٨	%١٥,٢	١٦٧	%٦٦,٨		
المجموع	٦٦	%٢٦,٤	٤٢	%١٦,٨	٤٩	%١٩,٦	٥٥	%٢٢,٠	٣٨	%١٥,٢	٢٥٠	%١٠٠,٠		

كشفت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بالعلاقة الارتباطية بين النوع والخدمات عن فروق جوهرية ذات دلالة احصائية عند مستوي دلالة ٠,٠٠١ وقيمة احصائية بلغت ٢٠٤,٣ حيث احتل متغير الكشف المرتبة الاولى بنسبة بلغت ٢٦,٤% ثم احتل الاشاعة والتحليل في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٢٢,٠% ثم احتل العلاج بالمجان في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ١٩,٦% ثم احتل الرعاية في المرتبة الرابعة بنسبة قد

بلغت ١٦,٨% ثم احتل العمليات المرتبة الخامسة بنسبة قد بلغت ١٥,٢% وجود علاقة طردية ذات دلالة احصائية بين النوع والخدمات التي تقديمها المبادرات الصحية

وتتفق نتائج الدراسة الميدانية مع دراسة^{٢٧} Johanna, Hanefeld. Et al

في ضمان وصول الخدمات والعلاج وهو ما يظهر في استفادة النساء بالنسبة الأكبر بالرعاية الصحية وأختلفت مع باقي الدراسات.

وفي ضوء الدراسة الراهنة فأن إقبال النساء علي خدمات الكشف أكثر من الذكور بسبب دورهن في الرعاية الصحية للأسرة وارتفاع الوعي الصحي لديهن بأضافة الي طبيعة تلك المبادرات التي غالباً ما تستهدف النساء بشكل مباشر فالعديد من المبادرات الرئاسية موجهة أساساً للمرأة، مثل: مبادرة صحة المرأة المصرية و مبادرات الكشف عن سرطان الثدي وهذا ما يجعل المرأة أكثر استهدافاً وبالتالي أكثر حضوراً في هذه الخدمات .

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية الدور حيث يمكن تحليل تصدر خدمة الكشف الصحي ضمن أولويات المبادرات الرئاسية الصحية والتي تبين أن سلوك الأفراد يتأثر بالأدوار الاجتماعية التي يتوقع منهم تأديتها ففي السياق الصحي ، تتناط بالمرأة بأدوار الرعاية والوقاية داخل الأسرة ، مما يجعلها أكثر إقبالاً على خدمات الكشف المبكر حفاظاً على صحة أفراد الأسرة والمجتمع لذلك تعكس المبادرات الرئاسية هذا الفهم، حيث تركز على تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض ، استجابة للدور المجتمعي المتوقع من المواطنين في حماية أنفسهم ومن ، كما أن تخصيص هذه المبادرات لخدمات الكشف الصحي المجاني والمنظم يسهم في تمكين الأفراد ، خصوصاً النساء ، من أداء أدوارهم الصحية والاجتماعية بشكل فعال للقيام بأدوارهم الصحية على النحو الأمثل ، كما تساهم هذه المبادرات في تعزيز الوعي الجماعي بأهمية الاكتشاف المبكر للأمراض كخطوة وقائية أساسية ويتضح أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اهتمام المبادرات الصحية

²⁷ Johanna, Hanefeld. Et al." How Have Global Health Initiatives Impacted on Health Equity? What strategies can be put in place to enhance their positive impact and mitigate against negative impacts? "A literature review commissioned by the Health Systems Knowledge Network ", International Development Research Center, Ottawa, Canada,2007.

بالكشف المبكر، وبين ما تطرحه نظرية الدور من مسؤوليات وسلوكيات تتبع من توقعات المجتمع ، مما يعكس العلاقة بين السياسة الصحية والدور الاجتماعي للمواطنين .

جدول رقم (6)

يوضح معدلات نوع المرض التي تم اكتشافه اثناء المشاركة في المبادرة الصحية

نوع المرض المكتشف	التكرارات	النسبة المئوية
سرطان الثدي	٧٢	%٢٨,٨
فيروس سي	٥٦	%٢٢,٤
ارتفاع ضغط الدم	٤٧	%١٨,٨
السمنة	٤٥	%١٨,٠
السكر	٣٠	%١٢,٠
المجموع	٢٥٠	%١٠٠

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (6) عن احتلال نوع المرض وجاء سرطان الثدي في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت %٢٨,٨ وجاء فيروس سي في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت %٢٢,٤ وجاء ارتفاع ضغط الدم في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت %١٨,٨ وجاء السمنة في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت %١٨,٠ وجاء السكر في المرتبة الخامسة بنسبة قد بلغت %١٢,٠

وتتفق نتائج الدراسة الميدانية الحالية مع دراسة^{٢٨} Sana Al-Sukhun et al

al " في أن السرطان أصبح أحد الأسباب الرئيسة للمرض والوفيات ليس فقط في البلدان ذات الدخل المرتفع، ولكن أيضاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

ولم تختلف نتائج الدراسة الميدانية الراهنة " معدلات نوع المرض التي تم اكتشافه اثناء المشاركة في المبادرة الصحية " مع أي من الدراسات السابقة

وفي ضوء الدراسة الراهنة فأن ارتفاع نسبة مرض سرطان الثدي يعد من أبرز التحديات الصحية الموجودة اليوم ويرجع هذا الي اساليب الحياه الغير صحية والاستخدام

²⁸ Sana Al-Sukhun et al.; "Global Health Initiatives Of The International Oncology Community", American Society of Clinical Oncology Educational Book ,Volume 37, 2017.

المفرط للأدوية او وجود تاريخ مرضي في العائلة كما ان خطر الاصابة بمرض سرطان الثدي يرتفع مع تقدم العمر للمرأة

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية التنمية المستدامة ما دامت نسبة الاهتمام بالسرطان من القضايا الصحية التي تدرج ضمن اهتمامات نظرية التنمية المستدامة، والتي تركز على تحقيق التوافق بين متطلبات العصر والأجيال القادمة ، مع ضمان توفير حياة صحية وكرامة للجميع ويصل هذا المرض تحديًا بالهدف الثالث من أهداف تطوير العمل، وهو: "ضمان شامل للجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية" وتمثل سرطان الثدي تحديًا أمام تحقيق هذا الهدف ، نظرًا لعدم انتشاره بشكل متزايد بين النساء بشكل رئيسي على جودة الحياة والوسادة النفسية والجسدية والإنتاجية المجتمعية ولذلك، إن دمج جهود مكافحة السرطان ضمن المبادئ الصحة الوطنية ، والمبادرات الصحية ، لذلك تشكل تشكيلاً عملياً للتنمية والعمل، من خلال ضمان الحصول على الرعاية الصحية ، وتمكين المرأة صحياً واجتماعياً ، بما في ذلك المساهمة في استقرار الأسرة للمجتمع.

جدول رقم (7)

يوضح معدلات السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة لاطلاق المبادرات الصحية

الاسباب الرئيسية لاطلاق المبادرات الصحية	التكرارات	النسبة المئوية
الحد من انتشار الامراض المزمنة	١٣٣	٥٣,٢%
تخفيف الضغط علي المستشفيات	٥٧	٢٢,٨%
توفير رعاية صحية عادلة للفئات اكثر احتياجا	٣٦	١٤,٤%
تحسين جودة الحياة	٢٤	٩,٦%
المجموع	٢٥٠	١٠٠

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (7) عن احتلال السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة لاطلاق المبادرات الصحية وجاء الحد من انتشار الامراض المزمنة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٥٣,٢% وجاء تخفيف الضغط علي المستشفيات في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٢٢,٨% وجاء توفر رعاية صحية في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ١٤,٤% وجاء تحسين جودة الحياة بنسبة قد بلغت ٩,٤%

وتتفق نتائج الدراسة الراهنة مع دراسة " رشاشا عبدالرحمن حجازي " ^{٢٩} في وجود دور مؤثر للمبادرات الرئاسية في رفع الوعي الصحي لديهم كما أكد من أفراد العينة البحثية أن الحملة جعلتهم يمارسون نشاطات صحية، كان أبرزها اتباع نظام غذائي صحي والحد من انتشار الأمراض كما أتفقت مع دراسة " Regien G Biesma et al. ^{٣٠} " التي أكدت علي تأثير المبادرات الصحية العالمية التي كانت لها تأثيرات عميقة على أنظمة الرعاية الصحية .

ولم تختلف نتائج الدراسة الراهنة " معدلات السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة لاطلاق المبادرات الصحية " مع أي من الدراسات السابقة .

وفي ضوء الدراسة الراهنة فإن الحد من الأمراض هو حجر الأساس في إطلاق المبادرات الصحية لأنها تخدم أهدافاً اجتماعية ، اجتماعية ، وإنسانية ، وتعزيز مناعة المجتمع في التحديات الصحية ، مع تقليل التكاليف وكذلك جودة الحياة ، وتؤدي الأمراض إلى غياب الأشخاص عن العمل وانخفاض معدل الإنتاج ، اما الوقاية ، فتمكن المواطنين من الاستمتاع بصحة جيدة ، مما يدعم التنمية ، فتعمل المبادرات الصحية الي الوصول للفئات الغير القادرة إلى الخدمات الصحية ، مما يبرسخ العدل والمساواة في الحد من انتشار الأمراض وينعكس ذلك إيجابياً على مؤشرات الصحة العامة .

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية الدور فإن كل دور اجتماعي هو مجموعة الحقوق والواجبات والتوقعات والمعايير والسلوكيات التي يجب علي الشخص مواجهتها وتحقيقها ، وهو ما يعبر عن الأداء الوظيفي الذي يقوم به كل جزء من أجزاء المجتمع في إطار القيم والمعايير السائدة في المنظمات والجماعات التي يتكون منها المجتمع وفقاً للنظرية ، يتبع كل فرد في المجتمع مجموعة من القضايا الاجتماعية المتنوعة ولكن عند إصابتهم بالأمراض يفشلوا في أداء أدوارهم ، مما يؤدي إلى إضعاف بنية المجتمع ، لذلك ، تهدف

^{٢٩} رشاشا عبدالرحمن حجازي : دور الحملات الاعلانية في تشكيل الوعي الصحي للمرأة المصرية (دراسة تطبيقية على مبادرة ١٠٠ مليون صحة) ، مجلة البحوث الإعلامية ، العدد ٥٣ ، الجزء 2 ، كلية الاعلام ، جامعة الازهر ، ٢٠٢٢م .

³⁰ Regien G Biesma et al; "The Effects Of Global Health Initiatives On Country Health Systems: A Review Of The Evidence From HIV/AIDS Control Health Policy And Planning", Global Health initiatives And Health Systems, Published by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine ,2009.

الدولة من خلال المبادرة الصحية إلى وقاية الأشخاص من الأمراض حتى يتمكن كل شخص إلى أداء دوره الطبيعي فكلما قلّت نسبة الأمراض ، زادت قدرة الأشخاص للقيام بدورهم .

جدول رقم (8)

يوضح العوائق التي تواجه تنفيذ المبادرات الصحية

العوائق	التكرارات	النسبة المئوية
نقص التمويل	٦٠	%٢٤,٠
ضعف التنسيق بين الجهات الصحية	٨٥	%٣٤,٠
قلة التدريب والتأهيل المناسب	٤٦	%١٨,٤
نقص الكوادر الطبية المساعدة	٥٩	%٢٣,٦
المجموع	٢٥٠	%١٠٠

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (8) عن احتلال ضعف التنسيق بين الجهات الصحية بنسبة قد بلغت %٣٤,٠ وجاء نقص التمويل في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت %٢٤,٠ وجاء نقص الكوادر الطبية المساعدة في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت %٢٣,٦ وجاء قلة التدريب في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت %١٨,٤

وتتفق نتائج الدراسة الميدانية مع دراسة " Jeremy Shiffman, Stephanie

^{٣١}Smith" في ان بعض المبادرات الصحية العالمية بالأولوية من القادة السياسيين الدوليين والوطنيين بينما تحظى مبادرات أخرى بالحد الأدنى من الاهتمام وذلك يؤدي الي ضعف التنسيق بين الجهات الصحية الفاعلة. وأيضاً مع دراسة " Aziza Mwisongo, Juliet Nabyonga -Orem^{٣٢} " في ان هياكل حوكمة المبادرات الصحية العالمية منفصلة عن تلك الموجودة في البلدان التي تعمل فيها ، وقد ساهمت قنوات التمويل المختلفة في فشل الحكومات في تتبع مواردها الصحية.

³¹ Jeremy Shiffman, Stephanie Smith;" **Generation Of Political Priority For Global Health Initiatives: A Framework And Case Study Of Maternal Mortality**", The Center for Global Development, Working Paper No.129, Published in The Lancet, Volume 370, 2007.

³² Aziza Mwisongo, Juliet Nabyonga -Orem; " **Global Health Initiatives In Africa Governance, Priorities, Harmonization And Alignment**", BMC Health Services Research, Volume 16, Suppl 4, Mwisongo and Nabyonga-Orem BMC Health Services Research, 2016.

وتختلف مع دراسة " Regien G Biesma et all³³ " في ان أن مؤسسات الرعاية الصحية العالمية أصبحت تدرك بشكل متزايد أهمية تركيز الاهتمام على تمويل وتدريب وتحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملين الصحيين في المناطق الريفية باعتبارها استراتيجيات للاحتفاظ بهم .

وفي ضوء الدراسة الراهنة فإن ضعف التنسيق بين الجهات الصحية أحد العوائق الجوهرية التي تعيق تنفيذ المبادرات الصحية، وذلك لان عند غياب التنسيق ، قد تقوم جهات مختلفة بتنفيذ مهام متشابهة أو متداخلة دون معرفة أو تكامل ، مما يؤدي إلى تكرار غير ضروري للأنشطة ، وإهدار الموارد ، كما ان ضعف التنسيق يؤدي إلى توزيع غير عادل أو غير منظم للخدمات ، حيث قد تغطي مناطق معينة بشكل مفرط بينما تهمل مناطق أخرى ، مما يضعف العدالة الصحية ويحد من انتشار أثر المبادرة ، ويقلل التنسيق الضعيف من مشاركة البيانات والخبرات بين الجهات ، مما يحرم المبادرة من إمكانية التحسين المستمر أو التعلم من النجاحات والإخفاقات السابقة ، فضعف التنسيق بين الجهات الصحية يؤدي إلى تضارب الأدوار و إهدار الموارد ، ويفقد المبادرات الصحية قدرتها على الوصول المتكامل والمنظم إلى المستفيدين ، ما يقلل من فاعليتها ويهدد استدامتها فلذلك ، يعد التنسيق المؤسسي الفعال من الركائز الأساسية لإنجاح أي مبادرة صحية وطنية.

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية الدور في أن ضعف التنسيق يعد بين الجهات الصحية من أبرز المعوقات التي تؤثر سلباً على تنفيذ المبادرات الصحية ، حيث يؤدي الي عدم إحداث التكيف والتوافق بين أجزاء النسق مما ينعكس مباشرة على جودة التنفيذ وفعالية النتائج ، وهنا تظهر العلاقة الواضحة مع نظرية الدور لانه الأسلوب الذي يؤدي به الشخص السلوك المطلوب منه في موقف ما حسب المعايير المرسومة ، فغياب التنسيق يقلل من كفاءة العاملين ، ويؤدي إلى فشل في تحقيق أهداف المبادرة بالشكل المطلوب ، كما ان إن ضعف التنسيق بين الجهات الصحية لا يضعف فقط الأداء التنفيذي للمبادرات الصحية ، بل ينتج خللاً في توزيع الأدوار .

³³ Regien G Biesma et all; "The Effects Of Global Health Initiatives On Country Health Systems: A Review Of The Evidence From HIV/AIDS Control Health Policy And Planning", Op. Cit .

جدول رقم (9)

يوضح الوسائل والاليات التي تعتمد عليها الدولة لتفعيل المبادرات الصحية

الوسائل والاليات	التكرارات	النسبة المئوية
حملات توعية عبر الاعلام	٥٤	٢١,٦%
توفير خدمات صحية مجانية	٨٦	٣٤,٤%
دعم البحث العلمي والابتكار في الصحة	١٠٠	٤٠,٠%
شراكات مع القطاع الخاص	١٠	٤,٠%
المجموع	٢٥٠	١٠٠%

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (9) عن احتلال دعم البحث العلمي والابتكار في الصحة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٤٠,٠% وجاء توفير خدمات صحية مجانية في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٣٤,٤% وجاء حملات توعية عبر الاعلام في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ٢١,٦% وجاء شراكات مع القطاع الخاص في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت ٤,٠%

وتتفق نتائج الدراسة الميدانية مع دراسة " Ross L. Prentice, Garnet L. Anderson"

حيث أكدت علي أهمية البرامج البحثية في مبادرة صحة المرأة حيث أحدثت نتائج هذه التجربة المتعددة الأوجه تأثيراً كبيراً في الممارسة الحياتية وتعمل كمصدر لمعلومات جديدة عن عوامل الخطر وتوفر تقييماً مراقباً مقارناً لتدخلات التجارب الحياتية ويعد مستودع العينات وبيانات النتائج الخاضعة لمراقبة الجودة لمجموعة من الأمراض من بين الموارد التي تدعم برنامج البحث الجاري ، كما تتم مراجعة ومناقشة مساهمات وتحديات التجارب الصحية لمبادرة صحة المرأة.

ولم تختلف نتائج الدراسة الميدانية مع أي من الدراسات السابقة حول الوسائل

والاليات التي تعتمد عليها الدولة لتفعيل المبادرات الصحية

وفي ضوء الدراسة الراهنة فأن البحث العلمي يساعد على تشخيص المشاكل الصحية بعناية ، وفهم أسبابها وسلوكها في المجتمع ، لذلك تسعى الدول إلى تحسين صحة مواطنيها من خلال المبادرات الصحية ، لكن هذه المبادرات لا تكون فعالة بدون أساس

³⁴ Ross L. Prentice, Garnet L. Anderson; "The Women's Health Initiative: Lessons Learned", Op. Cit .

علمي قوي وحلول مبتكرة ، لذلك ، فإن دعم البحث العلمي والابتكار الصحي يعتبر من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق هذه الأهداف عن طريق توفر بيانات وإحصاءات يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات صحية سليمة كما يوفر البحث العلمي دلائل علمية تساعد صناع القرار في تصميم المبادرات بناءً على احتياجات حقيقية وليس افتراضات ، كما انه ضرورة استراتيجية لتفعيل المبادرات الصحية ، وتحقيق نظام صحي عادل وفعال وقابل للاستمرار لذلك ، فإن الدول التي تعطي الأولوية للعلم والابتكار في الصحة ، تكون أكثر استعدادًا لمواجهة التحديات ، وأكثر قدرة على خدمة المواطنين بشكل حقيقي.

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية التنمية المستدامة في ان دعم البحث العلمي يعد محاوراً أساساً في تحقيق تلك التنمية وذلك البشر هم صميم التنمية المستدامة ، وأن من حقهم أن يحيا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة ، ولا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا إذا تم القضاء على الأمراض الراهنة التي تنتشر بكثرة ، وتم تحقيق مكاسب صحية للبشر كافة ويتعين تعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية على توفير الخدمات الصحية الأساسية للجميع على أسس الكفاءة وسهولة المنال وبسرعة التكلفة للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومعالجتها والتقليل من الأخطار الصحية البيئية ، بما يتماشى مع حقوق الإنسان ، وأيضاً تعزيز إمكانية الحصول بصورة منصفة ومحسنة ، على خدمات رعاية صحية كفؤة ورخيصة ، تشمل الوقاية على كافة مستويات النظام الصحي ، والحصول على العقاقير الضرورية المأمونة بأسعار ميسورة ، وخدمات التحصين واللقاحات المأمونة ولذلك فإن البحث العلمي يقدم حلول صحية مبتكرة أكثر فاعلية ومنخفضة التكلفة وهذا ما تشير الية النظرية بضروره تحقيق نمو اقتصادي مستدام ، وذلك من خلال المساهمة في توفير الأدوات الضرورية لاتخاذ قرارات استراتيجية صحية قائمة على أسس علمية ومدروسة.

جدول رقم (10)

يوضح معدلات مساهمة المبادرات الصحية في تحقيق التنمية المستدامة

النسبة المئوية	التكرارات	مساهمة المبادرات الصحية
٢٢,٠%	٥٥	تحسين جودة الحياة
٣٤,٤%	٨٦	تقليل تكاليف العلاج
٤٠,٠%	١٠٠	تقليل الامراض المزمنة
٣,٦%	٩	تعزيز الشراكة بين جهات الحكومية والخاصة
١٠٠%	٢٥٠	المجموع

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (10) عن احتلال تقليل الامراض المزمنة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٤٠,٠% وجاء تقليل تكاليف العلاج في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٣٤,٤% وجاء تحسين جودة الحياة في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ٢٢,٠% وجاء تعزيز الشراكة بين جهات الحكومية والخاصة في المرتبة الرابعة بنسبة قد بلغت ٣,٦%

وتتفق نتائج الدراسة الميدانية مع دراسة " حمري نجود^{٣٥} " في أن التحسين في ظروف وتوقعات الحياه له أثر إيجابي علي الصحة، فالبيئة النظيفة والتغذية الأفضل تولد صحة جيدة وهي نتيجة ارتفاع في مستويات الدخل كما أن الصحة المتردية تؤثر على العمل والأنتاج ومن ثم على الدخل القومي وهذا ما يؤثر مباشرة علي مسيرة التقدم واستدامة التنمية ولذلك فان البرامج الخاصة بالتغذية والرعاية الصحية والصحة البيئية مطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة ، كما أن التنمية المستدامة لا تتحقق الا من خلال يد عاملة تتمتع بصحة جيدة لأن إنتاجية العمل تتوقف على عاملين : المهارة الفردية وكفاءة عنصر العمل داخل الوحدات الإنتاجية ، كما إتفقت مع " ياسر إبراهيم محمد وآخرون^{٣٦}" حيث أن رأس المال الاجتماعي وخاصة بقطاع الصحة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر ، و تبني استراتيجيات وطنية لتمويل التنمية المستدامة

^{٣٥} حمري نجود : اقتصاديات الصحة للدول النامية في ظل متطلبات التنمية المستدامة (حاله بعض الدول العربية و الافريقية) ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد ١٧ ، العدد ٢٥ ، جامعة حسنية بن بو علي بالشلف - مخير العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا ، الجزائر ، ٢٠٢١م.

^{٣٦} ياسر إبراهيم محمد داود ، عصام احمد البدري : دور تحسين خدمات الرعاية الصحية و العلاجية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمصر ، المجلة العلمية للدراسات و البحوث المالية و التجارية ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، الجزء ٤ ، كلية التجارة ، جامعة دمياط ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢م.

وتحديد المصادر الفعلية لتمويل الخطط والأهداف التنموية علي أن يراعى البدء بتمويل الخدمات الاجتماعية في المجتمع المصري خاصة الصحية ، وإيضاً أتفقت الدراسة مع دراسة " Eko Priyo purnomo, et all³⁷ " فأن اطار أهداف التنمية المستدامة في تعزيز التنمية يعمل على تحسين أداء الحكومة و الزام الحكومة بتنفيذ أنشطة لتحسين التنمية مثل الخدمات الصحية التي يجب تقديمها بشكل كاف للمجتمع و تحقيق تنمية ذات جودة وان أهداف تنمية الموارد الصحية الثلاثة تلعب دوراً مهماً في تنفيذ الأداء لتقديم الصحة العامة .

تختلف نتائج الدراسة الميدانية مع دراسة " محفوظ عرابي³⁸ " في أن المشاكل والمعوقات التي يعاني منها القطاع الصحي تقع خارج قطاع العناية الصحية وبالتالي فان تحقيق تنمية صحية مستدامة قد يقتدرن بقطاعات أخرى ذات علاقة مباشرة والتأثير القوي على القطاع الصحي .

وفي ضوء الدراسة الراهنة فأن المبادرات الصحية تلعب دوراً فعالاً في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة ، وتؤثر بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث ان الاستثمار في الصحة ليس عنصراً إنسانياً ، بل هو أساس لبناء مجتمع سليم، واقتصاد مننعش ، وبيئة إجتماعية مستقرة ، فمساهمة المبادرات الصحية في تقليل الأمراض المزمنة وتحقيق التنمية المستدامة هي من أهم الركائز الأساسية للنظام الصحي ، حيث ترتبط الصحة ارتباطاً وثيقاً بجودة الحياة والإنتاجية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي ، وذلك من خلال حملات التوعية بأهمية المبادرات الصحية و الكشف المبكر والفحوصات الدورية والتطعيمات المجانية وتطوير مراكز الرعاية الأولية ، وذلك يعمل علي تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج الفعال.

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية التنمية المستدامة حيث ان المبادرات الرئاسية الصحية هي مبادرات تقوم بها الدول أو المؤسسات أو الأفراد وتشتمل فى برامج أعمالها

³⁷ Eko Priyo purnomo, et all. ; "Analysis of Sustainable Health Development Goals in Improving Public Health, Research Articles , Vol 19 , No 2 , University of Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia , 2020.

³⁸ محفوظ عرابي : إرساء دعائم التنمية الصحية المستدامة في الجزائر من أجل تحسين ظروف المعيشة و تحقيق رفاهية المجتمع ، المجلة الدولية للأداء الاقتصاد ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، ٢٠٢٠ م .

أنشطة متنوعة في مجالات مختلفة لتحسين صحة الأفراد من خلال التوعية، الوقاية، العلاج وبذلك يتم تحقيق التنمية الصحية المستدامة و تغيير معارف الأفراد إلي أنواع من السلوك والعادات تؤدي إلي الوقاية من الأمراض وعودتهم سريعاً إلي الصحة إذا انتابهم المرض ، وإلمام المواطنين بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤولية نحو صحتهم وصحة الآخرين وبهذا يتم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها : الهدف الأول لا فقر والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه الهدف العاشر الحد من عدم المساواة

جدول رقم (11)

يوضح دور الدولة في دعم المبادرات الصحية

النسبة المئوية	التكرارات	دور الدولة في دعم المبادرات الصحية
١٢,٨%	٣٢	تمويل البرامج الصحية
٣٥,٦%	٨٩	نشر التوعية الصحية
٥١,٥%	١٢٩	تدريب الكوادر الصحية
١٠٠%	٢٥٠	المجموع

كشفت نتائج الدراسة الميدانية بجدول رقم (11) عن احتلال تدريب الكوادر الصحية في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٥١,٥% وجاء نشر التوعية الصحية في المرتبة الثانية بنسبة قد بلغت ٣٥,٦% وجاء تمويل البرامج الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة قد بلغت ١٢,٨%

وفي ضوء الدراسة الراهنة فإن الكوادر الطبية تمثل القاعدة الثابتة في نجاح أي هيكل علاجي حيث تؤدي دوراً أساسياً في توفير الرعاية والعلاج ، فتساهم في تحسين جودة العيش وخفض تفشي الأمراض ، وتحقيق الإنصاف الصحي بين جميع شرائح المجتمع ، فالكوادر الصحية هم كالأساس السري لمجتمع معافى، فتدريبهم ومساندتهم يغير نوعية العناية بالصحة ويساعد علي حصول الجميع على نفس الفرص، فطالما نهتم وننمي ونساعد الكوادر الطبية، تتحسن صحة الناس والمجتمع ككل ويتم تحقيق المساواة الاجتماعية .

وتتفق نتائج الدراسة مع نظرية الدور وهي التي تفسر سلوك الأفراد في المجتمع من خلال الأدوار التي يقومون بها ، والتي تحددها التوقعات الاجتماعية ، فكل فرد يشغل

دوراً محدداً بناءً على مركزه الاجتماعي ، ويتوقع منه أداء سلوكيات معينة تتلاءم مع ذلك الدور، حيث نتوقع من الأطباء والممرضين وبقية العاملين في المجال الصحي أن يكونوا مزودي الرعاية ، مخلصين في العمل ، متعاطفين مع المرضى ، وملتزمين بأخلاقيات المهنة ، فالمجتمع يرى فيهم أفراداً مسؤولين عن الصحة العامة ، الوقاية من الأمراض ، والاستجابة للطوارئ الصحية ، نظرية الدور تشير إلى أن كل دور تحيط به طائفة من التوقعات .

عاشراً : النتائج والتوصيات :

أولاً : النتائج :

- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال مبادرة دعم صحة المرأة في المرتبة الاولى بمعدلات نوع المبادرة التي استفادوا منها بنسبة قد بلغت ٦٦,٨%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال مبادرة دعم صحة المرأة في العلاقة بين النوع ونوع المبادرة في المرتبة الاولى بنسبة قد بلغت ٦٦,٨% .
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال الشباب في المرتبة الأولى كأكثر الفئات المستهدفة من المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٤٠,٠%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال الوقاية من الامراض في المرتبة الاولى لأسباب المشاركة في المبادرات الصحية من قبل افراد العينة بنسبة قد بلغت ٣٩,٦%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال الكشف في المرتبة الاولى بمعدلات الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٢٦,٤%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال نوع المرض وجاء سرطان الثدي في المرتبة الاولى بالبحث عن نوع المرض التي تم اكتشافه اثناء المشاركة في المبادرة الصحية بنسبة قد بلغت ٢٨,٨%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن الحد من انتشار الامراض المزمنة في المرتبة الاولى بمعدلات البحث عن السبب الرئيسي الذي يدفع الدولة لاطلاق المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٥٣,٢%.

- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال ضعف التنسيق بين الجهات الصحية كأهم العوائق التي تواجه تنفيذ المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٣٤,٠%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال دعم البحث العلمي والابتكار في الصحة في المرتبة الاولى كأهم الوسائل والاليات التي تعتمد عليها الدولة لتفعيل المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٤٠,٠%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن احتلال تقليل الامراض المزمنة في المرتبة الاولى بمعدلات مساهمة المبادرات الصحية في تحقيق التنمية المستدامة بنسبة قد بلغت ٤٠,٠%.
- كشفت نتائج الدراسة الميدانية احتلال تدريب الكوادر الصحية في المرتبة الاولى لدور الدولة في دعم المبادرات الصحية بنسبة قد بلغت ٥١,٥%.

ثانياً : التوصيات :

- ضرورة العمل علي التنسيق بين الجهات الصحية المختلفة عن طريق إنشاء أهداف مشتركة و منصات رقمية موحدة لتعزيز المعلومات والخبرات، وذلك لمحاولة تقليل ضعف التنسيق الذي يمكن أن يكون من أهم العوائق التي تعوق تنفيذ المبادرات الصحية .
- ضرورة رفع نسبة التمويل الحكومي على الصحة لضمان تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة ومنصفة .

المراجع :

المراجع العربية :

١. احسان محمد الحسن : النظريات الاجتماعية المتقدمة (دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة) ، دار وائل للنشر ، الطبعة ٣ ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ٢٠١٥م.
٢. اسلام صلاح : الاتجاهات النظرية في دراسة الاستراتيجيات الحديثة في إدارة الأزمات وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة ، رساله دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة الفيوم ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢م .
٣. بن عرعار بقة و سيهام عبدالعزيز : مؤشرات التنمية الصحية في الجزائر ، مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم الانسانية والاجتماعية ، المجلد ١٠ ، العدد ٤ ، جامعة زيان عاشور ، الجزائر ، ٢٠٢٣م .
٤. بومعروف إلياس و آخرون: من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر ، مجلة الباحث ، المجلد ٧ ، العدد ١ ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، ٢٠٠٩م ، ص ٢٧.
٥. تغريد حسن الغوطي : واقع الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والمؤسسات الأهلية الصحية وأثرها على استدامة الخدمات الصحية بقطاع غزة ، مجلة الاقتصاد والمالية JEF ، المجلد 9 ، العدد ٢ ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، الجزائر ، ٢٠٢٣م .
٦. جوناثان تيرنز : ترجمة محمد سعيد فرح : بناء نظرية علم الاجتماع ، منشأ المعارف ، جامعة الإسكندرية ، ٢٠٠٦م .
٧. حمري نجود : اقتصاديات الصحة للدول النامية في ظل متطلبات التنمية المستدامة (حاله بعض الدول العربية و الافريقية) ، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا ، المجلد ١٧ ، العدد ٢٥ ، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف - مخبر العولمة واقتصاديات شمال إفريقيا ، الجزائر ، ٢٠٢١م.
٨. حنان عبدالسلام : برنامج في الجغرافيا الطبية قائم علي نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات التفكير السابر والوعي بالتنمية الصحية المستدامة لدي طلاب المدارس الثانوية الفنية للتمريض ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية ، العدد ١٣٧ ، جامعة عين شمس ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢م .
٩. داليا عثمان إبراهيم : اتجاهات المرأة المصرية نحو استخدام الاعلام الرقمي في المجال الصحي ، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام ، مجلد ١٨ ، العدد ٣ ، كلية الاعلام ، جامعة القاهرة ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٩م .

١٠. رحالي حجيبة وآخرون : التنمية من مفهوم تنمية الاقتصاد إلى مفهوم تنمية البشر ، مجلة دراسات في التنمية والمجتمع ، العدد ٣ ، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، الجزائر ، ٢٠١٥ م .
١١. رزقي نور الهدي : دور النفقات الصحية في تحقيق التنمية الصحية المستدامة في الجزائر للفترة ٢٠٠٠-٢٠١٨ بالمقارنة مع تونس والمغرب -دراسة تحليلية ، المجلة الجزائرية للمالية العامة ، المجلد ١٠ ، العدد ٢ ، جامعة فرحات عباس سطيف ، الجزائر ، ٢٠٢٠ م .
١٢. رشا عبدالرحمن حجازي : دور الحملات الاعلانية في تشكيل الوعي الصحي للمرأة المصرية (دراسة تطبيقية على مبادرة ١٠٠ مليون صحة) ، مجلة البحوث الإعلامية ، العدد ٥٣ ، الجزء 2 ، كلية الاعلام ، جامعة الازهر .
١٣. سعيدة رحمانية : تقييم الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العمومية من وجهة نظر المرضى " دراسة ميدانية بالمؤسسات الصحية العمومية بمدينة قسنطينة " ، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ، المجلد ١٣ ، العدد ٤ ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة ، الجزائر ، ٢٠٢١ م .
١٤. سلوي السيد عبدالقادر : الرؤية المجتمعية لتمكين الشباب والتنمية البشرية المستدامة :دراسة أنثروبولوجية ، مجله كليه الآداب للأنسانيات والعلوم الاجتماعية ، المجلد ١١ ، العدد ٢٠ ، كليه الآداب ، جامعه الاسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠١٩ م .
١٥. فاطمة محمد فؤاد: برنامج مقترح في خدمة الجماعة لتدعيم دور جماعة الهلال الأحمر في تنمية الثقافة الصحية للطلاب ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة حلوان ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٠٦ م .
١٦. محفوظ عرابي : إرساء دعائم التنمية الصحية المستدامة في الجزائر من اجل تحسين ظروف المعيشة و تحقيق رفاهية المجتمع ، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، ٢٠٢٠ م .
١٧. محفوظ عرابي: إرساء دعائم التنمية الصحية المستدامة في الجزائر من أجل تحسين ظروف المعيشة وتحقيق رفاهية المجتمع ، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، جامعة مولود معمري ، الجزائر ، ٢٠٢٠ م .
١٨. محمد فتحي عبد الغني : تطور مفهوم التنمية المستدامة وأبعاده ونتائجها ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية السياسة والاقتصاد ، جامعة بني سويف ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٠ م .

١٩. محمد كمال احمد: المبادرات الصحية الرئاسية وتغيير المنظومة الصحية في مصر ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الجزء ٢ ، العدد ٣٠ ، كلية الآداب ، جامعة السويس ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٠ م .
٢٠. محمود حبيب : دراسة واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي ٢٠٠٠م - ٢٠١٠م ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٣٧ ، العدد ٢ ، جامعة تشرين ، سوريا ، ٢٠١٥ م .
٢١. محمود حبيب : دراسة واقع مؤشرات التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية ما بين عامي ٢٠٠٠م - ٢٠١٠م ، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد ٣٧ ، العدد ٢ ، جامعة تشرين ، سوريا ، ٢٠١٥ م .
٢٢. منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير : تقديم خدمات صحية عالية الجودة : ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة ، منظمة الصحة العالمية ، جنيف ، ٢٠١٩ م
٢٣. منظمة الصحة العالمية: المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية: إجراءات مستدامة عبر القطاعات من أجل تحسين الصحة والإنصاف في مجال الصحة (متابعة المؤتمر العالمي الثامن بشأن تعزيز الصحة) ، جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون ، البند ١٤-٥ من جدول الأعمال المؤقت ١٨ مايو ٢٠١٥ م .
٢٤. مؤيد اسعد ناجي : دور جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تحقيق التنمية الصحية من وجهة نظر العاملين والمستفيدين في شمال الضفة الغربية ، جامعة القدس ، ٢٠١١ م .
٢٥. نبيلة محمد لطفي : عرض تحليلي للمبادرات الرئاسية باستخدام نماذج الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية ، المجلد ٣٢ ، العدد ١ ، كلية الخدمة الاجتماعية ، جامعة الفيوم ، جمهوريه مصر العربية ، ٢٠٢٣ م.
٢٦. ياسر إبراهيم محمد داوود ، عصام احمد البديري : دور تحسين خدمات الرعاية الصحية و العلاجية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمصر ، المجلة العلمية للدراسات و البحوث المالية و التجارية ، المجلد ٣ ، العدد ٢ ، الجزء ٤ ، كلية التجارة ، جامعة دمياط ، جمهورية مصر العربية ، ٢٠٢٢ م.

المراجع الأجنبية :

1. Aziza Mwisongo, Juliet Nabyonga -Orem; “ **Global Health Initiatives In Africa Governance, Priorities, Harmonization And Alignment**”, BMC Health Services Research, Volume 16, Suppl 4, Mwisongo and Nabyonga-Orem BMC Health Services Research, 2016.
2. Eko Priyo purnomo, et all. ;”**Analysis of Sustainable Health Development Goals in Improving Public Health**, Research Articles , Vol 19 , No 2 , University of Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia , 2020.
3. Jeremy Shiffman, Stephanie Smith;” **Generation Of Political Priority For Global Health Initiatives: A Framework And Case Study Of Maternal Mortality**”, The Center for Global Development, Working Paper No.129, Published in The Lancet, Volume 370, 2007.
4. Johanna, Hanefeld. Et al." **How Have Global Health Initiatives Impacted on Health Equity? What strategies can be put in place to enhance their positive impact and mitigate against negative impacts?** "A literature review commissioned by the Health Systems Knowledge Network ", International Development Research Center, Ottawa, Canada,2007.
5. Kunt Lonnorth, ET.all “**The Who’s New End TB Strategy In The Post – 2015 Era Of The Sustainable Development Goals**”, world health organization, Geneva, Switzerland ,2015.
6. Leslie L. Hemphill: “**Social Role Theory As A Means Of Differentiating Between First -Generation, Non-First – Generation College Students**”, Department of Counseling and Education, Physiology College of Education, KANSAS STATE UNIVERSITY, Manhatten, Kansas ,2008.
7. Regien G Biesma et all; “**The Effects Of Global Health Initiatives On Country Health Systems: A Review Of The Evidence From HIV/AIDS Control Health Policy And Planning**”, Global Health initiatives And Health Systems, Published by Oxford University Press in association with The London School of Hygiene and Tropical Medicine ,2009.
8. Ross L. Prentice, Garnet L. Anderson; “**The Women's Health Initiative: Lessons Learned**”, Annual Review of Public Health, Volume 29, 2008.
9. Sana Al-Sukhun et al.; “**Global Health Initiatives Of The International Oncology Community**”, American Society of Clinical Oncology Educational Book ,Volume 37, 2017.

Abstract

The present study aimed to observe and analyze the underlying reasons and driving factors that led policymakers to launch presidential health initiatives. It also sought to identify the target beneficiaries, the mechanisms used to implement these initiatives, and the impact of their application on both individuals and society. To achieve this, the study posed a central research question:

What are the main reasons behind the state's launch of presidential health initiatives?

This study falls within the scope of **descriptive and analytical research**, employing a **social survey method** applied to a **purposive sample** of citizens benefiting from the presidential health initiatives.

Key Findings:

- The results of the field study (Table 1) revealed that the **"Women's Health Support Initiative"** ranked first among the types of initiatives beneficiaries engaged with, at a rate of **66.8%**.
- The results of Table 4, which addressed reasons for participating in health initiatives, showed that **disease prevention** ranked first, with **39.6%** of respondents citing it as their primary motivation.
- According to Table 9, which explored the tools and mechanisms used by the state to implement health initiatives, **supporting scientific research and innovation in health** ranked first, with **40.0%** of the sample recognizing it as a key activation strategy.